



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 14-08-2024 20:24:50

Página 1 de 5

Información Paciente

Nombre	: Jose Luis Chavez Diaz	Rut	: 19.458.520-9	N° Archivo	: 2421834	N° Epicrisis	
Edad	: 28a 1m 4d	Fecha Nacto	: 10/07/1996	Sexo	: Masculino		410103
Dirección	: Manuel Rodríguez Guez 631 Sector Centro	Comuna	: La Serena	Teléfono	: 9 9808 9364		

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso	: Upc - Uci Adulto	Fecha Ingreso	: 12/08/2024	06:20	Días Estadía	: 2
Unidad de Egreso	: Upc - Uci Adulto	Fecha Egreso	: 14/08/2024	20:08		

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Falla hepatica para trasplante hepatico

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiologia

Resumen Clínico

CAMA 6:
JOSE LUIS CHAVEZ DIAZ
28 AÑOS
19458520-9
Nombre: José Luis Chávez Díaz
Edad: 28 años
RUT: 19458520-9
Fecha Nacimiento: 10/07/1996
Previsión: FONASA A
Fecha Ingreso Hospital de La Serena: 30/07/2024

ANAMNESIS:
NGRESO UCI MODULO A
12/08/2024

Antecedentes
Médicos/Quirúrgicos: Cirrosis hepática Child C en estudio. Várices esofágicas pequeñas (EDA mayo 2024). Asma bronquial leve. Orquiectomía izquierda (infancia).
Fármacos: Salbutamol SOS.
Alergias (-). OH (-). Tabáquicos (-)
Paciente vive con familia adoptiva (madre biológica con consumo patológico de alcohol y pasta base durante la gestación).

Clínica larvada de 8 meses de evolución de aumento de volumen progresivo en relación a extremidades inferiores y perímetro abdominal. Evaluado por gastroenterología en CDT Hospital de La Serena, destaca con clínica compatible con cirrosis hepática descompensada, realizándose EDA en mayo 2024, revelando várices esofágicas pequeñas. Además, clínicamente con ascitis grado 3. El 29/07 presenta disnea progresiva, instaurándose de reposo. Evaluado por SAMU, es trasladado a Urgencias HLS, con ingreso posterior a UTI del mismo centro dada clínica y radiología compatible con edema pulmonar agudo. Se dispone de secuencia de TAC de abdomen y pelvis que describe cirrosis hepática asociada a hipertensión portal (esplenomegalia, desarrollo circulación colateral portosistémica y ascitis). Exámenes de ingreso destaca creatinina 0.77, Bili. Tot. 10.8 (Dir. 5.04), FA/GGT 243/34, GOT/GPT 108/81, Albúmina 1.8, PCR 15, Hb 12.4 (VCM 98/35), GB 3940 (RAN 3440, RAL 340), Plq. 87000.

Fecha Epicrisis : 14/08/2024 20:24

Página 1 de 5

Fecha Última Actualización: 14-08-2024 20:24:50

Página 2 de 5

INR 3.1, Na⁺/K⁺/Cl⁻: 130/3.6/100. En UTI inicia apoyo ventilatorio con VMNI CPAP 8 alternando con CNAF, asociado a terapia depleitiva. Evoluciona de forma tórpida a las pocas horas de ingreso, destacando febril, somnoliento y con deterioro de mecánica ventilatoria. En el intertanto se realiza paracentesis diagnóstica + mini evacuación (1460 cc de líquido peritoneal), la que descarta PBE y con GASA compatible a etiología de HT portal. Se inició antibioterapia empírica + toma de cultivos periféricos. Debido a mala respuesta evolutiva en cuanto a nivel de conciencia (no lograba deposiciones pese a lactulosa enteral y por enema) y por signos de fatiga respiratoria, se decide intubar y conectar a VMI (01/08). Se traslada a UCI, donde se mantiene sin sedación, acoplado en VMI en modo Espontáneo con Ps, optimizándose terapia diurética y laxantes asociados (lactulosa + PEG), permitiéndose extubar a CNAF el 02/08. De momento, se rescata estudio etiológico, destacando con serología de VHB (-), VHC (-), VIH (-), ASMA (-), LKM1 pendiente, AMA (-), ANA + 1/80 AC-4 (inespecífico), IgG 1450, Ferritina 265, Saturación 41%, Ceruloplasmina 23 (dentro de rango de referencia de laboratorio), Alfa 1 antitripsina pendiente. Sin conflicto renal. Alimentándose vía enteral por SNG. Estable en lo metabólico. El 06/08 se realiza paracentesis hasta *¿dry tap¿*, lográndose evacuar 1200 cc, de características similares a estudio previo, sin PBE. El 08/08 presenta TTPK incoagulable, por lo que se decide transfundir con 2 U de plasma fresco congelado. Para la tarde de ese día evoluciona con sobrecarga de volumen y mayor apremio ventilatorio. Se inició furosemida en altas dosis EV y se conecta a VMNI, presentando un episodio de emesis (no hubo evidencia objetiva de broncoaspiración). Más que nada por profundización del deterioro del nivel de conciencia es que fue necesario reintubarlo (08/08). Se inició antibioterapia de segunda línea, se tomó CAET y se lleva a TC cerebro (sin hallazgos patológicos) y tórax (que revela focos de relleno alveolar y opacidades pulmonares bilaterales más sugestivos de edema alveolar por sobrecarga). Se suspende antibioterapia (procalcitonina y PCR bajas), con CAET polimicrobiano. Se mantiene acoplado a VMI en espontáneo sin sedoanalgesia, aunque sin lograr adecuado nivel de conciencia pese a deposiciones hasta 3 veces al día (Bristol 5). Control tomográfico del día de hoy describe ausencia de hallazgos patológicos en encéfalo, así como TC de tórax que denota moderado derrame pleural bilateral y opacidades pulmonares en regresión compatibles con edema alveolar. Control de perfil hepático y función de síntesis en franco deterioro. Se toma ecocardiograma portátil (Dr. Rangel) el 11/08, que informa *¿Buenas ventanas ecográficas. Cavidades cardíacas de tamaño normal. Septum IV: 0.9. Sin regurgitación valvular ni estenosis. FeVI estimada 65%, con motilidad conservada. TAPSE 2.2 cm. Normotensión pulmonar. VCI 1.4 cm*".

Debido a tendencia oligúrica refractaria a administración de albúmina, así como hipotensión, inicia noradrenalina para PAM 75 *¿* 80 mmHg como parte de protocolo de manejo de Síndrome hepatorenal.

Exámenes 11/08/2024: Crea 3.05 BUN 60 Urea 129 Amonio 143 BiliT 31 Dir 10.6 GOT/GPT 5478/1640 FA/GGT 245/40.9 PCR 5.5 PCT 0.10 Hb 6.1 Gb 10720 Plq 23K INR 10 pH 7.46 PCO2 35 PaFi >300 Na⁺/K⁺/Cl⁻ 145/4.76/105 Se suspenden diuréticos y betabloqueo. Inicia volemicización cuidadosa con albúmina y noradrenalina. Cumple con criterio de falla hepática aguda sobre crónica, requiriendo PFC por falla de síntesis hepática *¿* inicia N-AC empírico. Mantiene rifaximina 400 mg c/8 hrs. Evaluado caso por equipo de trasplante, quien da criterios para traslado. Se traslada a este centro (vía aérea) el día 11/08 para manejo y evaluación in situ por equipo de trasplante.

Diagnósticos de ingreso a UCI:

- Insuficiencia respiratoria aguda, secundaria a sobrecarga de volumen por hemocomponentes (TACO)
- Cirrosis hepática descompensada
- à ACLF CLIF 39 pto / MELD 41 pto
- Síndrome hepatorenal tipo AKI
- Cirrosis hepática Child C en estudio
- Antecedentes

FI HSR 12/08

FI UPC HSR 12/08

FI Hospital de la Serena 30/07/2024

DIAGNÓSTICOS:

- 1.- Hipertensión endocraneana severa + lesiones hemorrágicas pequeñas
Pérdida de reflejos de tronco - Sin indicación neuroquirúrgica
- 2.- Shock Distributivo resuelto
Vasoplejía en contexto de falla hepática?
- 2.- HDA versus Sangrado orofaríngeo
- 3.- Falla hepática aguda sobre crónica?, de etiología desconocida
MELD > 40 puntos
CLIF - C ACLF 29 puntos

Fecha Epicrisis : 14/08/2024 20:24

Página 2 de 5

Fecha Última Actualización: 14-08-2024 20:24:50

Página 3 de 5

Síndrome hepatorenal
Ascitis Grado II
Hipoglicemia
Coagulopatía severa
4.- Insuficiencia respiratoria aguda
Derrame pleural leve mod a derecha, sospecha sobrecarga de volumen versus pleuroascitis
SDRA?
5.- AKI KDIGO III oligoanúrico
Con requerimientos de TRR
6.- Bicitopenia
Anemia severa, sin exteriorización de sangrado
Trombocitopenia severa
Antecedentes: Asma bronquial, DHC CHLD, Varices esofágicas pequeñas no ligadas

EXAMEN FÍSICO:

Hidratado límite, perfusión límite, tibio a distal
MP (+) se ausculta estertores difusos
RR2T no ausculto soplos, llene capilar 4s, yugulares planas
Abdomen: distendido, globuloso, BI, no palpo masas, sin blumberg, Ascítico
EEL: edema (++) sin signos de tvp
Neurológico: Paciente en coma, con sedoanalgesia suspendida, RFM (-) pupilas semimidriáticas arreactivas, sin asterixis, sin reflejo de tos/tubo
Faringe: con restos hemáticos antiguos, a ratos epistaxis bilateral, controlada

PLANES Y PROBLEMAS: Paciente de extremada gravedad en contexto de hallazgos a la imagen de cerebro + clínica concordante con signos de infarto de tronco cerebral, sin pronóstico neurológico funcional ni positividad en este de contexto de trasplante, por lo cual se conversa con familia y se explica, adecuación de esfuerzo terapéutico, acompañamiento en deceso del paciente en próximas horas, se mantiene soporte DVA para acompañamiento de familiares que viajaron desde la serena, NAD 0.08 ug/kg/min para PAM > 65 mmHg, conectado a VM en modo VC Vt: 430 PEEP: 10 Fio2: 60% Pplat: 23 FR: 24 .

Diuresis: BH:

Invasiones:

CVC yugular derecho: 02/08 - 13 días

LA BI: 01/08 - 14 días

Sonda Foley: 02/08 - 15 días

TOT: 07/08 - 8 días

SNG: 07/08 - 8 días

Catéter de HD 12/08 yugular izquierdo: 2 día

Plan:

HD: Paciente actualmente en shock distributivo, con monitorización invasiva con línea arterial, con uso de DVA noradrenalina, de momento debido a pronóstico neurológico adverso, fuera de alcance de tratamiento se suspende DVA a las 13:47

Ventilatorio: Paciente cursando con IRA moderada - severa, de momento en VMI en VC

Medio interno: Paciente con Insuficiencia hepática aguda grave con falla de síntesis, se suspende manejo debido a pronóstico neurológico adverso

Nefrológico: Paciente con SHR con requerimientos de TRR, se inició terapia de hemofiltración por 36 horas, con buena respuesta, pero sin poder lograr con esta su gravedad neurológica que limita el resto del proceso.

Hepatología: Paciente actualmente en insuficiencia hepática aguda con falla de síntesis (INR > 10), en seguimiento por equipo de trasplante. Se suspende avance manejo en relación a pronóstico neurológico adverso

Hematológico: Paciente con bicitopenia, con hemorragia en zona de punciones de catéteres, epistaxis, contexto de trombocitopenia, Se decide realizar transfusiones:

Fecha Epicrisis : 14/08/2024 20:24

Página 3 de 5

Fecha Última Actualización: 14-08-2024 20:24:50

Página 4 de 5

12/08: GR 1 PLT 6 PFC 4

13/08: GR 2 PLT 8 PFC 6 transfusion de 1 U GR + 1 pool de plaquetas para optimización en relación a procedimientos invasivos
Sin nuevos requerimientos

Infectológico: Paciente derivado desde Hospital de La Serena, actualmente según lo descrito en ficha, sin microbiología aislada, además completa terapia antibiótica por 14 días con 1 y 2° línea (no se especifica). Se decide pancultivar e iniciar terapia empírica con Imipenem + Vancomicina en dosis de carga. Se suspende tto debido a pronóstico neurológico adverso

Neurológico: Paciente cursa con estado de mínima conciencia. TC de cerebro con signos de hipertensión endocraneana severa y signos de isquemia de tronco encefálico, fuera de alcance manejo médico y neuroquirúrgico que genera pronóstico ominoso, se decide no progresar en manejo sin posibilidad de otra terapia que permite continuar en plan de trasplante por lo cual equipos de neurocirugía y hepatobiliar de acuerdo de paciente sin pronóstico en plan de acompañamiento por familiares en últimas horas del paciente con cuidados de fin de vida

Se da info en visita a hermana tutora y dos familiares más que vienen desde la Serena al tanto de gravedad, al tanto de no rta a manejo debido a evento neurológico sin pronóstico con manejo y al tanto de acompañamiento terminal, agradecen esfuerzos refieren estar claros de la gravedad y pronóstico del paciente y refieren entender información dada y desenlace fatal.

Se constata fallecimiento en la unidad A6 de la UCI a dulto hoy 14 de agosto 2024 a las 19:36hr.

se diligencia certificado de defunción número 4143809 y se entrega a Hermana tutor y se explica trámites a seguir en anatomía patológica para retiro del paciente en esa unidad con la funeraria.

Diagnóstico de Egreso

FIBROSIS Y CIRROSIS DEL HIGADO -

Choque, no especificado -

Insuficiencia Renal Aguda -

Insuficiencia Respiratoria aguda -

EDEMA CEREBRAL -

Anemia en estudio -

DEFECTOS CUALITATIVOS DE LAS PLAQUETAS -

DEFECTO DE LA COAGULACIÓN, NO ESPECIFICADO -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J: NO

Se da info en visita a hermana tutora y dos familiares más que vienen desde la Serena al tanto de gravedad, al tanto de no rta a manejo debido a evento neurológico sin pronóstico con manejo y al tanto de acompañamiento terminal, agradecen esfuerzos refieren estar claros de la gravedad y pronóstico del paciente y refieren entender información dada y desenlace fatal.

Se constata fallecimiento en la unidad A6 de la UCI a dulto hoy 14 de agosto 2024 a las 19:36hr.

se diligencia certificado de defunción número 4143809 y se entrega a Hermana tutor y se explica trámites a seguir en anatomía patológica para retiro del paciente en esa unidad con la funeraria.

Plan Post Alta

Se da info en visita a hermana tutora y dos familiares más que vienen desde la Serena al tanto de gravedad, al tanto de no rta a manejo debido a evento neurológico sin pronóstico con manejo y al tanto de acompañamiento terminal, agradecen esfuerzos refieren estar claros de la gravedad y pronóstico del paciente y refieren entender información dada y desenlace fatal.

Se constata fallecimiento en la unidad A6 de la UCI a dulto hoy 14 de agosto 2024 a las 19:36hr.

se diligencia certificado de defunción número 4143809 y se entrega a Hermana tutor y se explica trámites a seguir en anatomía patológica para retiro del paciente en esa unidad con la funeraria.

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Fecha Epicrisis : 14/08/2024 20:24

Página 4 de 5



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 14-08-2024 20:24:50

Página 5 de 5

Controles

INTERNO

Becado/Residente


John Fredy Gamboa Murcia
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 14/08/2024 20:24

Página 5 de 5

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:22

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar